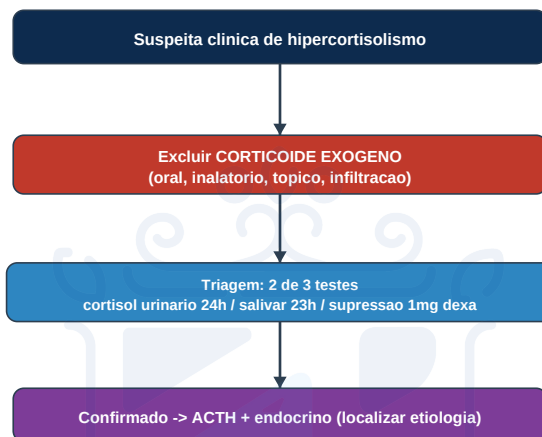


SÍNDROME DE CUSHING — RECONHECER E TRIAR

FLUXOGRAMA — INVESTIGAÇÃO

CUSHING — EXCLUIR CORTICOIDE, DEPOIS TRIAR



DEFINIÇÃO

O QUE É

- Conjunto de sinais/sintomas da exposição prolongada e inapropriada a níveis elevados de cortisol
- Causa MAIS COMUM: corticoide exógeno (iatrogênica)
- Endógena: ACTH-dependente (70-80%) ou ACTH-independente (20-30%)
- ACTH-dependente: Doença de Cushing (adenoma hipofisário, maioria microadenoma) e ACTH ectópico
- ACTH-independente: adenoma adrenal, carcinoma adrenocortical, hiperplasias adrenais

QUADRO CLÍNICO — ACHADOS DISCRIMINATÓRIOS

MAIS ESPECÍFICOS DE CUSHING

- Estrias purpúreas (> 1 cm), violáceas — abdome, coxas, axilas
- Pletora facial, equimoses fáceis sem trauma, pele fina e frágil
- Fraqueza muscular PROXIMAL (dificuldade de levantar da cadeira/subir escadas)
- Fácies em lua cheia, giba dorsal (buffalo hump), obesidade centrípeta
- Osteoporose/fraturas vertebrais precoces; em crianças: ganho de peso COM baixa estatura

REPERCUSSÕES METABÓLICAS E SISTÊMICAS

Sistema	Manifestação	Frequência / pista
Cardiometabólico	HAS, DM2/hiperglicemia, dislipidemia	HAS em 50-75%; DM recente/descompensado
Eletrolítico	Hipocalcemia	Especialmente no ACTH ectópico
Musculoesquelético	Miopatia proximal, osteoporose, fraturas	Fraturas vertebrais > 50%
Neuropsiquiátrico	Depressão, psicose, déficit cognitivo	Risco aumentado de suicídio
Reprodutivo/imune	Amenorreia, hirsutismo, infecções de repetição	Imunossupressão, má cicatrização

PERGUNTAS-CHAVE

ANAMNESE DIRIGIDA

- Usa/usou corticoide? Oral, pomadas/cremes, inalatório, infiltração articular, fórmulas magistrais?
- Surgiram estrias roxas? Hematomas fáceis? Pele mais fina?
- Ganho de peso rápido? Mudança no formato do rosto? 'Bola' atrás do pescoço?
- Dificuldade para levantar da cadeira / fraqueza proximal? Fraturas sem trauma?
- DM ou HAS de início recente/difícil controle? Alterações de humor? Amenorreia/hirsutismo?

EXAMES — TRIAGEM E ETIOLOGIA

INVESTIGAÇÃO LABORATORIAL

- 1o passo: EXCLUIR uso de glicocorticoide exógeno antes de investigar
- Realizar 2 de 3 testes de triagem:
- Cortisol livre urinário 24h (2-3 amostras) | Cortisol salivar noturno 23h-meia-noite (2 amostras)
- Supressão com 1mg dexametasona overnight: cortisol $\geq$ 1,8 ug/dL sugere Cushing
- 2 testes positivos -> confirma hipercortisolismo endógeno; 2 normais -> improvável
- Diferenciação: ACTH plasmático matinal (suprimido = adrenal; normal/alto = hipofisário/ectópico)

TRATAMENTO POR ETIOLOGIA

Etiologia	Tratamento	Observação
Doença de Cushing	Cirurgia transesfenoidal	Adenoma hipofisário
ACTH ectópico	Ressecção do tumor primário	Buscar fonte (pulmão, timo)
Adenoma adrenal	Adrenalectomia unilateral (laparoscópica)	ACTH-independente
Carcinoma adrenocortical	Cirurgia aberta + linfadenectomia	Pior prognóstico
Exógena (iatrogênica)	Redução/retirada GRADUAL do corticoide	Risco de insuficiência adrenal

ATENÇÃO — RETIRADA DO CORTICOIDE

NÃO SUSPENDER ABRUPTAMENTE

- A causa mais comum de Cushing é iatrogênica — o tratamento é desmame GRADUAL
- Suspensão abrupta de corticoide crônico -> crise de insuficiência adrenal (potencialmente fatal)
- Orientar dose de estresse em intercorrências (infecção, cirurgia, trauma)
- Cushing é majoritariamente investigação/seguimento ambulatorial — no PS, reconhecer e triar

MODELO DE ENCAMINHAMENTO — ENDOCRINOLOGIA

RESUMO PARA ENCAMINHAR

- Paciente com triagem positiva para hipercortisolismo (achados: estrias violáceas, pletora, fraqueza proximal, giba).
- Uso de corticoide exógeno: sim/não (especificar via).
- Triagem: cortisol urinário ____ | salivar 23h ____ | pós-dexametasona ____ | ACTH ____.
- Impacto metabólico: HAS de difícil controle / DM recente / osteoporose precoce.
- Encaminhamento à endocrinologia para localização etiológica e definição terapêutica.

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual é a causa MAIS COMUM de síndrome de Cushing?

- A) Adenoma hipofisário (doença de Cushing)
- B) Carcinoma adrenocortical
- C) Uso de glicocorticoides exógenos (iatrogênica)
- D) Secreção ectópica de ACTH
- E) Hiperplasia adrenal bilateral

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual achado clínico é mais ESPECÍFICO (discriminatório) de síndrome de Cushing?

- A) Obesidade isolada
- B) Hipertensão arterial
- C) Estrias purpúreas largas (> 1 cm) e fraqueza muscular proximal
- D) Diabetes mellitus
- E) Ganho de peso difuso

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Sobre o teste de supressão com 1 mg de dexametasona (overnight), o resultado sugestivo de Cushing é:

- A) Cortisol sérico matinal $\geq 1,8$ ug/dL (ausência de supressão)
- B) Cortisol suprimido abaixo de 1,8 ug/dL
- C) ACTH elevado isoladamente
- D) Glicemia de jejum elevada
- E) Cortisol urinário normal

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Após confirmar hipercortisolismo endógeno, qual exame inicial diferencia causa adrenal de hipofisária/ectópica?

- A) Cortisol salivar noturno
- B) ACTH plasmático matinal (suprimido = adrenal; normal/alto = hipofisário/ectópico)
- C) Glicemia de jejum
- D) Cortisol livre urinário
- E) Eletroforese de proteínas

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Paciente em uso crônico de prednisona com fácies cushingoide deseja parar o corticoide. Qual a conduta correta?

- A) Suspende abruptamente o corticoide
- B) Reduzir/retirar o corticoide de forma gradual, pelo risco de insuficiência adrenal
- C) Dobrar a dose do corticoide
- D) Iniciar quimioterapia
- E) Realizar adrenalectomia bilateral

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: C

A causa mais comum de síndrome de Cushing é a exógena/iatrogênica (uso de glicocorticoides por qualquer via). Por isso, o 1o passo da investigação é sempre excluir corticoide exógeno antes de testes.

QUESTÃO 2 → Resposta: C

Obesidade, HAS e DM são comuns e inespecíficos. Estrias purpúreas largas (>1cm), pletora, equimoses fáceis e fraqueza muscular proximal são os achados mais discriminatórios do hipercortisolismo.

QUESTÃO 3 → Resposta: A

No teste de supressão overnight com 1mg de dexametasona, o normal é suprimir o cortisol. Cortisol $\geq 1,8$ ug/dL às 8h indica ausência de supressão, sugestivo de síndrome de Cushing.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Confirmado o hipercortisolismo, o ACTH plasmático diferencia: suprimido aponta causa adrenal (ACTH-independente); normal ou elevado aponta causa hipofisária ou ectópica (ACTH-dependente).

QUESTÃO 5 → Resposta: B

O corticoide crônico suprime o eixo HHA; a retirada deve ser gradual. Suspensão abrupta precipita crise de insuficiência adrenal, potencialmente fatal. Orientar dose de estresse em intercorrências.

SM24
Suporte ao Plantão Médico